

POST-AMM

Chapitre 6 : Remboursement des produits de santé

Objectifs	– Savoir quelles sont les parties décisionnaires du remboursement d'un produit de santé. - Commission de transparence - CNéDiMTS – Connaître les critères et la procédure de fixation du taux de remboursement d'un produit de santé remboursable.
-----------	---

Quelles sont les parties décisionnaires du remboursement d'un produit de santé ?

→ La commission de transparence pour les médicaments

→ La CNéDiMTS pour les DM

I.- Classification des médicaments :

Classification des médicaments	
Selon la santé publique	- Les produits listés à Prescription Médicale Obligatoire (PMO) - Les produits non listés = en vente libre, auxquels appartiennent les produits à prescription médicale facultative (PMF)
Selon leur milieu d'utilisation	- Produits réservés au milieu hospitalier - Produits utilisables en ambulatoire
Selon la protection sociale	- Produits pris en charge par un organisme de protection sociale, avec un prix administré, régulé et fixé par l'État - Produits non pris en charge avec un prix librement fixé par l'industriel

II.- Modalités de remboursement des médicaments : la Commission de Transparence :

Une fois l'AMM obtenu, les indications définitives de produit ont été précisées et le laboratoire va être à même de fournir 2 dossiers de demandes s'il veut que son produit soit inscrit sur la liste des spécialités remboursables.

- Dossier 1 : technique --> commission de la transparence (commission rattachée à la HAS)

- Dossier 2 : économique --> comité économique des produits de santé CEPS

HAS	• Instance d'avis • Évaluer d'un point de vue médical et économique : produits, actes, prestations et technologies de santé, en vue de leur remboursement • Évaluation de l'utilité des biens et services qu'on leur soumet • Contribue à la régulation du système de santé par la qualité et l'efficacité avec un objectif de résultat par rapport aux moyens • Élabore des recommandations sur les stratégies de prise en charge
Commission de transparence	• Une des 8 commissions spécialisées de la HAS (rattachée à la HAS depuis janvier 2005) • Instance scientifiques qui évalue les médicaments ayant obtenu leur AMM, lorsque le laboratoire qui les commercialise souhaite obtenir leur inscription sur la liste des médicaments remboursables. • Examine les demandes d'inscription, de réinscription ou d'extension d'indications thérapeutiques pour les produits qui doivent figurer sur : - o La liste des spécialités remboursables - et/ou o La liste des médicaments agréés aux collectivités

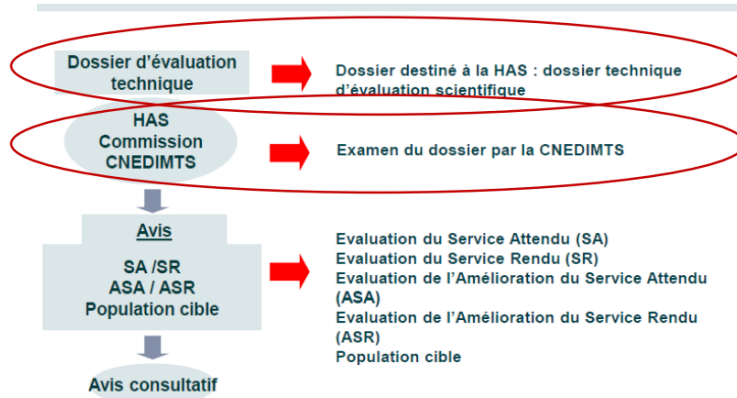
	→ Le laboratoire doit demander spécifiquement l'inscription sur l'une voire les deux listes (ne se fait pas automatiquement) • Réévalue les classes thérapeutiques pour éventuellement modifier le SMR-> peut aboutir éventuellement à des remboursements • Donne un avis sur des documents relatifs au bon usage du médicament (établi des fiches de transparence, des recommandations, des référentiels de bon usage) • Rédige la Fiche d'Information Thérapeutique (FIT) => réservée aux médicaments d'exception → Le médicament remboursable représente 75% du marché du médicament.
--	---

III.- Conditions de prise en charge :

Code de la sécurité sociale	• Les médicaments sont inscrits sur la liste des spécialités remboursables au vu de leur Service Médical Attendu (si le produit est nouveau) / Rendu (SMA/SMR), et ceci indication par indication. • La validité de l'inscription des médicaments est de 5 ans au plus mais peut être renouvelée et/ou peut être modifiée.
Critères	5 critères liés à la valeur intrinsèque du produit pour établir le niveau de SMA/SMR : - o Efficacité du produit + effets indésirables du produit => balance bénéfice/risque - o Place du produit dans la stratégie thérapeutique (au regard des autres thérapeutique proposées) - o Gravité de l'affection à laquelle le produit est destiné - o Caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux - o Son intérêt pour la santé publique française → Ceci se fait par rapport à l'évaluation de la population cible. (qui bénéficie du traitement) → Évaluation se fait <u>indication par indication</u> donc un même médicament peut comporter, selon les indications de son AMM, plusieurs SMR différents. → Le niveau de SMR/SMA conditionne le taux de prise en charge. → Les médicaments dont le SMR est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles, ne sont pas inscrits sur la liste (donc pas de prise en charge = pas de remboursement). → Les génériques appartenant aux mêmes groupes génériques que les spécialités de référence, ne sont pas examinés par la Commission (ils ont automatiquement le même taux de prise en charge que le princeps dont ils dépendent).
Niveau SMR	<u>4 niveaux de SMR :</u> • 3 Niveaux « suffisants » pour lesquels la commission rend un avis favorable : - o SMR « important » = remboursement à 65 % - o SMR « modéré » = remboursement à 30 % - o SMR « faible » = remboursement à 15 % • 1 Niveau « insuffisant » : la commission rend un avis défavorable qui ne permet pas l'inscription sur la liste des médicaments remboursables <u>REMARQUE :</u> les médicaments considérés comme essentiels et indispensables ont un taux de remboursement à 100 % mais il n'est pas précisé de SMR pour ces produits.

Cas particulier	<u>Cas particulier : les médicaments d'exception :</u> • L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical. • Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du médicament sur la liste des médicaments remboursables, une fiche d'information thérapeutique (FIT) établie par la Commission de Transparence.
FIT	<u>Fiche d'Information Thérapeutique (FIT) :</u> • Destinée aux professionnels de santé • Rassemble indications thérapeutique + modalités d'utilisation du médicament en particulier règles de prescription et de délivrance. • Elle mentionne, le cas échéant, les restrictions apportées par l'AMM à la prescription et à la délivrance du médicament dit d'exception (médicaments soumis à prescription restreinte).
Agrément aux collectivités	• Pour être achetés et utilisés à l'hôpital, les médicaments doivent être inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics, établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la HAS. • Cet agrément aux collectivités est demandé, soit isolément, soit simultanément à la demande d'inscription sur la liste des spécialités remboursables.

III.- Modalités de remboursement des DM : la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé :

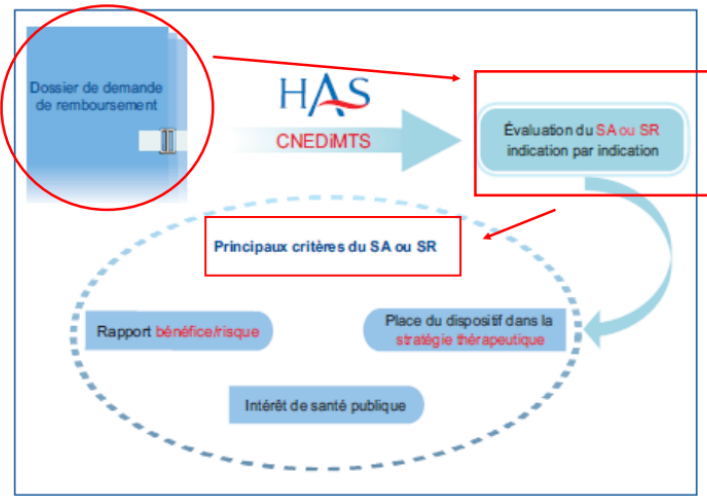


Pour les DM, une fois que le marquage CE est obtenu, le fabricant élabore un **dossier d'évaluation technique** destiné à la HAS et qui va servir de base pour que la commission dédiée aux DM de la HAS examine le dossier.

Cet examen aboutit à la **promulgation d'un avis** qui est relatif au service attendu ou service rendu du DM.

La CNEDiMTS	• Rattachée à la HAS • Examine toute question relative à l'évaluation et au bon usage des DM et des technologies de santé. • Formule des recommandations sur des bases scientifiques et rend des avis en vue du remboursement des DM à usage individuel (autre évaluation pour DM collectif) ou d'autres produits à visée diagnostique, thérapeutique ou de compensation du handicap (à l'exclusion des médicaments).
-------------	--

IV.- Conditions de prise en charge : Dispositifs médicaux- Les critères :

Dispositifs médicaux : SA/SR	• SA/SR et SMA/SMR : mêmes critères. • Population cible (susceptible de bénéficier du dispositif dans l'indication revendiquée). • Inscription sur la liste des produits ou prestations (LPP) – sous nom générique : démontrer l'équivalence du DM concerné avec un DM déjà inscrit. L'inscription est alors automatique. – ou nom de marque : faire un dossier complet à la CNEDiMTS
Quelle argumentation pour le Service Attendu ?	1- Description et évaluation du besoin médical • Gravité de la pathologie/handicap • Données épidémiologiques : prévalence/incidence • Évaluation de la population de patients concernés 2- Stratégie thérapeutique actuelle • Moyens thérapeutiques existants • Stratégie de référence • Place du DM évalué 3- Effet clinique du DM évalué • Effet thérapeutique /diagnostic /compensation du handicap / Risques • Fondé sur des études cliniques publiées ou à défaut des rapports d'études 4- Intérêt de santé publique • Impact prévisible sur le système de soins/ politique et programmes de santé publique • Impact potentiel sur la santé de la population
Appréciation du SA/SR par la CNEDiMTS	 <u>Résumé de la démarche :</u> 1) Industriel se présente avec le dossier de demande technique auprès de l'HAS 2) Commission dédiée va évaluer le SR ou le SA, indication par indication 3) Critères permettant de préciser le SA/SR : - o Rapport bénéfice/risque - o Positionnement du DM dans la stratégie thérapeutique - o Intérêt pour la santé publique

À retenir

- Le taux de remboursement d'un produit de santé est obtenu en fonction du service rendu qu'il présente (SMR/SR) en termes de santé publique.
- Des commissions de l'HAS (Commission de Transparence et CNEDiMTS), le détermine en fonction de la valeur intrinsèque du produit (balance bénéfice/risque ++).

Chapitre 7 : Fixation du prix des produits de santé

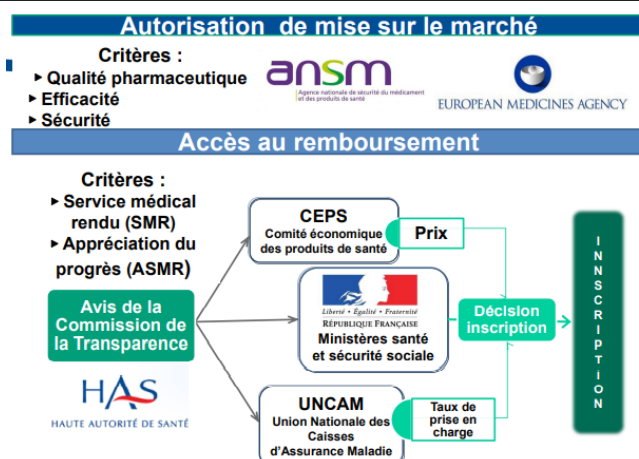
Objectifs	– Savoir quelles sont les parties décisionnaires dans la fixation du prix d'un produit de santé (produits remboursables, non remboursables). - CEPS – Connaître la procédure de fixation du prix d'un produit de santé remboursable. - ASMA/ASMR - ASA/ASR
-----------	--

I.- Fixation du prix :

Fixation du prix du médicaments : les critères	
Différentes catégories de spécialités selon le type de commercialisation : <pre> graph TD A[Spécialités non remboursées] --> B(Prix libre) C[Spécialités remboursées] --> D[Demande de remboursement] D -- "Par la Commission de Transparence" --> E[Fixation du prix] E -- "Par le CEPS" --> F[Décision finale UNCAM] </pre>	
Spécialités non remboursés	Spécialités admises au remboursement
Très simple : le laboratoire pharmaceutique va échapper à toutes autres évaluations et fixer lui-même librement le prix de son produit	- Demande de remboursement établie par l'avis de la commission de transparence en fonction du SA/SR - Remboursement admis ou non - Fixation du prix par le CEPS - Décision finale prise par l'UNCAM (Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie) puisque c'est elle qui rembourse
Procédure d'inscription	- Une fois que l'AMM est obtenue et qu'elle a précisé les indications du médicament, le laboratoire se doit de fournir deux dossiers de demande : 1) <u>Dossier technique</u> adressé à la Commission de Transparence pour la notion de prise en charge par l'Assurance Maladie 2) Si celle-ci est actée : un <u>dossier économique</u>, adressé au Comité Économique des Produits de Santé (CEPS)

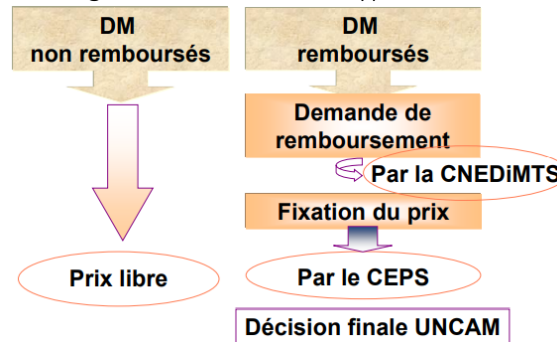
Rôle du Comité Economique des produits de santé (CEPS)	
Le CEPS	• Organisme interministériel, sous l'autorité conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie. • Principalement chargé par la loi, de fixer les prix des médicaments et les tarifs des DM à usage individuel (≠ DM collectif), pris en charge par l'assurance maladie (pour les autres, le prix est fixé librement par l'industriel). • 2 sections : - la section du médicament et - la section des DM
Prix de vente au public	• <u>La fixation du prix tient compte :</u> – de l'amélioration du service médical rendu (attendu) (ASMR/ASMA) apportée par le produit , – des prix des produits à même visée thérapeutique, – des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que, – des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du produit (rôle de la HAS).
ASMA/ASMR	= Appréciation de l'Amélioration de Service Médical Rendu (ou Attendu) • L'appréciation de l'ASMR fait appel à une évaluation comparative par rapport aux médicaments, déjà commercialisés dans la même indication. • Mesure du progrès apporté par le produit de santé par rapport au traitement de référence. • ASMR/ASMA représente la somme des avantages que procure le traitement en termes : - d'efficacité, - de tolérance, - d'utilité et - d'intérêt thérapeutique pour le malade. • Il s'agit en quelque sorte de la « valeur ajoutée relative » du produit de santé • Niveaux d'ASMR : cotation de I à V • Selon l'appréciation du progrès par rapport aux traitements ou la prise en charge déjà existants, l'amélioration est définie comme : – Niveau I Majeure – Niveau II Importante – Niveau III Modérée – Niveau IV Mineure – Niveau V Pas d'amélioration ⇔ absence de progrès thérapeutique : cas des génériques. • <u>Remarque</u> : un médicament peut très bien avoir un bon SMR en revanche un ASMR faible -> cela voudrait dire qu'il a une utilité thérapeutique mais qui n'apporte pas d'amélioration par rapport à des médicaments déjà commercialisés.

Résumé de l'étape de fixation du
remboursement et du prix du médicament



Fixation du prix : Dispositifs médicaux- Les critères

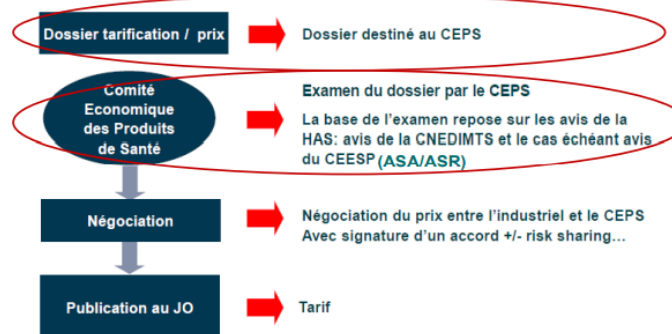
Différentes catégories de DM selon le type de commercialisation



Procédure d'inscription

La procédure suit la même logique :

- Pour les DM non remboursés : le fabricant peut fixer les prix lui-même, le **prix est libre**
- Pour les DM qui sont pris en charge par l'assurance maladie :
 - o Demande auprès de la HAS et de la CNEDiMTS
 - o Si la demande de remboursement est actée, la suite qui visera à fixer le prix sera similaire à celle des médicaments et s'adressera au CEPS
 - o La décision finale sera là aussi prise par l'UNCAM



CEPS

- Comme pour les médicaments, les DM font l'objet d'un dossier qui est destiné au CEPS.
- Le Comité Économique des Produits de Santé va évaluer le dossier et sur la base de l'avis qui est précisé par la CNEDiMTS, il va déterminer le prix en fonction de l'amélioration du service attendu ou l'amélioration du service rendu.

Prix de vente au public

De la même manière que pour les médicaments, la fixation du prix va tenir compte de :

- L'**amélioration du service rendu ou attendu** (si DM nouveau)
- Il s'agit encore d'une **évaluation comparative**, par rapport à :
 - produit, acte ou prestation **comparable**
 - précisément désignés, considérés comme **référence** selon les données actuelles de la science et **admis ou non** au remboursement.

o Remarque : on peut comparer à un produit remboursé ou non

DM : ASA/ASR

Nature de l'ASA

L'amélioration du service attendu ou rendu pour un DM peut être de différentes natures :

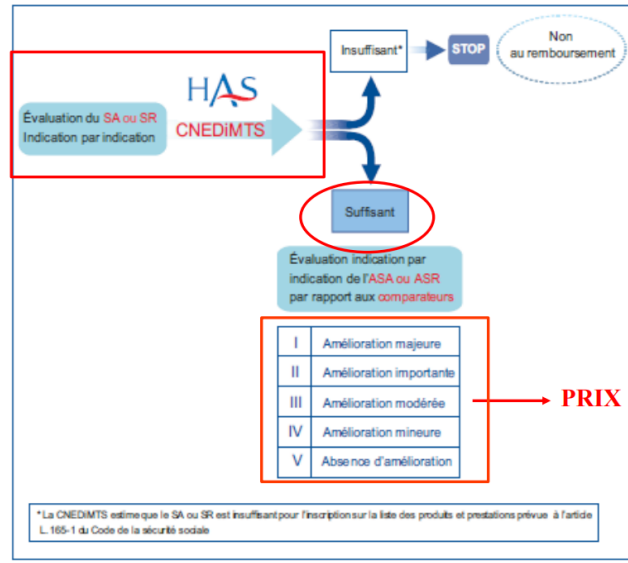
- amélioration clinique (mortalité, morbidité, compensation d'un handicap)
- amélioration de la qualité de vie
- amélioration en terme de tolérance
- amélioration des commodités d'emploi pour le patient

5 niveaux d'ASR/ASA

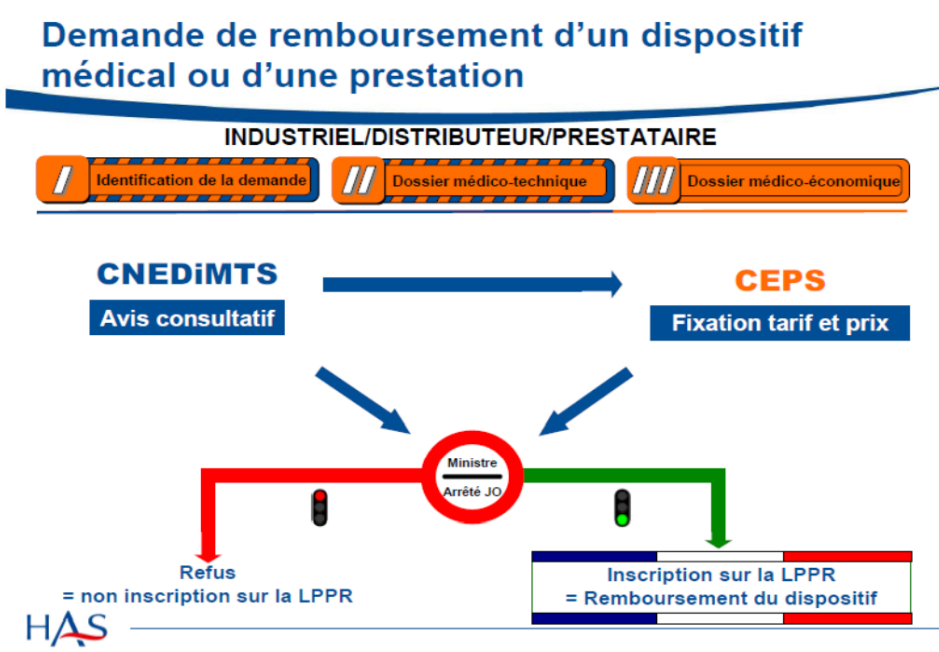
Les niveaux d'amélioration du service attendu ou rendu pour les DM sont les mêmes que pour ceux des médicaments :

- Niveau I Majeure
- Niveau II Importante
- Niveau III Modérée
- Niveau IV Mineure
- Niveau V Pas d'amélioration / pas de progrès thérapeutique : cas de la ligne générique.

Appréciation de l'ASA par la CNEDiMTS
Un produit qui revendique une **amélioration majeure** est plus à même de négocier un **prix élevé** qu'un produit pour lequel on constate une absence d'amélioration.



- Circuit réglementaire des DM
Résumé de l'ensemble du circuit réglementaire des DM :
- Demande de remboursement d'un DM
 - L'industriel va s'adresser à la CNEDiMTS pour acter la prise en charge par l'assurance maladie
 - Si celle-ci est approuvée, l'industriel s'adressera au CEPS avec l'aide d'un dossier médico-technique qui permettra, en fonction de l'amélioration du service attendu ou rendu, de fixer le prix
 - Approbation par le ministère de la santé : l'ensemble de la décision sera précisé et publié au journal officiel



II.- Participation de l'assuré :

- Elle est prévue au code de la **Sécurité Sociale**
- Fixée par le **conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie**
- Précise que dans certaines limites, elle peut être **supprimée** pour certains produits qui sont reconnus comme **irremplaçables et particulièrement coûteux** -> prise en charge intégrale
- Peut-être supprimée lorsque le bénéficiaire est reconnu comme atteint d'une **affection chronique**, qui nécessite une thérapie pendant un temps relativement long et surtout quand cette thérapie est coûteuse
- La liste des ALD30 est précisée par la HAS -> prise en charge intégrale

Participation de l'assuré	Article R322-1 du code de la SS La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2, est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) dans les limites suivantes : • Est supprimée pour certains produits reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, • Est supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapie particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la HAS (ALD30), pour les frais relatifs au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection dont le malade est reconnu atteint.
Taux de remboursement	Art. L162-16 Code SS <u>Les différents taux de remboursement (65/30/15) s'appliquent :</u> • soit sur la base du prix de vente qui a été fixée (parfois associé à un prix limite de vente fixé réglementairement par le CEPS) ; • soit sur la base d'un tarif forfaitaire de responsabilité (T.F.R.) : base pour le remboursement de certains médicaments (ex : génériques)

À retenir

- ANSM (Commission d'AMM) } → Autorisent le produit de santé
- ON (pour le marquage CE) }
- HAS (Commission de Transparence et CNéDiMTS) → Évaluent les produits de santé → prise en charge ou pas
- CEPS → Fixe le prix des produits de santé
- UNCAM → acte la décision finale par le biais du Remboursement (=prise en charge)

Chapitre 8 : Les produits de santé- Distribution en gros

Objectifs	– Connaître les différentes catégories d'établissements pharmaceutiques – Connaître le circuit de distribution pharmaceutique → La distribution en gros : les grossistes répartiteurs et les dépositaires
-----------	--

I.- La distribution en gros des produits de santé :

A) Les établissements pharmaceutiques :

Définition	• = Fond de commerce et d'industrie soumis à des règles particulières (précisées dans le CSP) qui trouvent leur origine dans l'intérêt de la santé publique. • Selon les activités pratiquées ⇔ différentes catégories d'établissements. • Ceci concerne les médicaments, mais aussi tous les produits et objets entrant dans le monopole pharmaceutique. (dont les Dms) • Ils ont l'interdiction légale de vendre directement au public les médicaments qu'ils fabriquent ou stockent (sauf dérogations visant les praticiens pour leur usage professionnel, les centres de vaccination, les centres de planification ou de vaccination familiale). • Il existe environ 950 établissements pharmaceutiques en France.
Catégories	<u>13 catégories d'établissements pharmaceutiques selon les activités pratiquées</u>: Décret du 11/02/1998 1. Le fabricant 2. L'importateur 3. L'exploitant 4. Le dépositaire 5. Le grossiste-répartiteur « médicaments » 6. Le grossiste-répartiteur « autres produits et objets » = (« distributeur ») <u>Les établissements de distribution de médicaments ou produits :</u> 7. destinés à l'exportation 8. à vocation humanitaire 9. de médicaments dérivés du sang 10. de médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme 11. de plantes médicinales 12. de gaz à usage médical 13. de service de santé des armées
Fonctionnement d'un établissement pharmaceutique	C'est un établissement dans lequel tout est contrôlé par l'ANSM : • L'ouverture de l'établissement est soumise à un agrément de la part de l'ANSM : - Cet agrément s'intéressera à l'état des lieux des locaux, l'état des lieux relatif au personnel, aux sous-traitances éventuellement que l'établissement peut avoir avec d'autres structures • Présence obligatoire d'un pharmacien responsable • Respect des Bonnes Pratiques de Fabrication (pour entreprises de fabrication) • Respect des Bonnes Pratiques de Distribution (pour entreprises de stockage et distribution) => L'ensemble de l'établissement est soumis à des inspections régulières.
Le pharmacien Responsable	• En France, le Pharmacien Responsable est doté d'une position statutaire (Art R-5124-36 du CSP), qui couvre des responsabilités plus larges que celles des « personnes qualifiées » sous le système actuel de l'U.E., telles que la qualité pharmaceutique, la PV (Pharmacovigilance) , la distribution et de la promotion. (= établissement de documents publicitaires à visées promotionnelles) • Il organise et supervise toutes les opérations pharmaceutiques de la société selon les activités du site pharmaceutique

Définition du CSP	Le Fabricant	• Fabricant : entreprise ou organisme se livrant, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur expérimentation sur l'homme, à la fabrication de médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et au 4^e de l'article L. 5121-1 (POD). • La fabrication comprend les opérations concernant (BPF) : – l'achat des matières premières et articles de conditionnement, – les opérations de production, de contrôle de la qualité, de libération des lots ainsi que, – les opérations de stockage correspondantes, telles qu'elles sont définies par les BP prévues à l'article L. 5121-5 applicables à cette activité.
	L'exploitant	• Exploitant : entreprise ou organisme se livrant à l'exploitation de médicaments (statut pharmaceutique s'appliquant aux opérations commerciales pour les médicaments en France) autres que des médicaments expérimentaux, générateurs, trousseaux et précurseurs mentionnés au 3^e de l'article L. 4211-1. • L'exploitation comprend les opérations de : – vente en gros ou de cession à titre gratuit, – stockage, – contrôle de la publicité, de l'information médicale, – pharmacovigilance, – suivi et de rappel des lots, – réclamations etc. • L'exploitation est assurée soit : – directement par le titulaire de l'AMM mentionnée à l'article L. 5121-8, de l'ATU mentionnée au 1^{er} du I de l'article L. 5121-12 ou de l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 (Med. homéop. et plantes traditionnelles), soit, – pour le compte de ce titulaire, par une autre entreprise ou un autre organisme, soit, – par l'un et l'autre, chacun assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories d'opérations constitutives de l'exploitation du médicament ou produit.

B) Et pour les DM ? :

Définition selon CSP	Le fabricant	• Le Fabricant : – Fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne. – Toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. – Celui qui procède à la remise en état du produit.
----------------------	--------------	---

II.- Les grossistes-répartiteurs : Les distributeurs :

A) Le circuit de distribution des produits de santé :

Définition	• Quel que soit le circuit choisi, le médicament, dès sa sortie des chaînes de production, doit être acheminé dans de bonnes conditions auprès des points de vente et/ou de dispensation, répartis sur l'ensemble du territoire.
Critères	• Cette distribution exige <u>3 critères</u> : – qualité, – régularité d'approvisionnement – rapidité d'approvisionnement • Selon l'activité, on distingue : les grossistes répartiteurs et distributeurs et les dépositaires.

Grossiste-Répartiteur	• <u>Grossiste-répartiteur</u> : entreprise se livrant à l'achat et au stockage de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme en vue de leur distribution en gros, et en l'état ».	
Distributeur	Code de la consommation	• Distributeur : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit.
	CSP	• Distributeur en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments : l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de produits et articles (conformes à la pharmacopée), générateurs, trousseaux ou précurseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4211-1 ou de POD mentionnés au 4° de l'article L. 5121- 1 en vue de leur distribution en gros et en l'état
	• Distributeur en gros de produits pharmaceutiques [autres que les médicaments] : – à l'exportation; – à vocation humanitaire; – de médicaments expérimentaux; – de plantes médicinales; – de gaz à usage médical; – du service de santé des armées; => Un même distributeur peut cumuler différentes activités <i>Exemple de grossiste-répartiteur distributeur : l'OCP, la CERP</i>	

Établissement pharmaceutique pour la protection de la population	• Établissement pharmaceutique ouvert par l'Agence nationale de santé publique, se livrant à des opérations d'achat, de fabrication, d'importation, d'exportation de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, en vue de leur distribution. • Ce sont des établissements qui sont là pour palier à un certain nombre de rupture de stock ou de manquement en terme d'approvisionnement sur l'ensemble du territoire français. • Créé par l'Agence Nationale de Santé Publique (ANSP) • Se livre, le cas échéant, à des opérations d'exploitation comprenant l'information, la pharmacovigilance, le suivi des lots et, s'il y a lieu, leur retrait ainsi que les opérations de stockage correspondantes.
Centrales d'achat pharmaceutiques	• Créées par le décret du 19 juin 2009. • Structures de Regroupement à l'Achat devenues Établissement Pharmaceutique, • Ils ont pour vocation d'acheter et stocker des médicaments, à l'exception des médicaments remboursables par l'AM, en vue de leur distribution en gros et en l'état, à des pharmaciens titulaires d'officine adhérents à des groupements. • On en recense une vingtaine en France, dont la majorité se trouve en Île de France et dans la région Centre (9 régions).
Les obligations légales	• Décret du 11 février 1998 (s'appliquent à tout établissement de répartition pharmaceutique) : – chaque établissement est sous la responsabilité d'un pharmacien responsable qui, selon l'effectif, est assisté d'un ou plusieurs pharmaciens délégués ; – doit desservir toutes les pharmacies qui leur en font la demande sur « le secteur d'activité déclaré » ; – doit référer au moins 9/10 (soit 90%) des présentations des médicaments exploitées en France, auxquelles s'ajoutent les accessoires médicaux ; – avoir un stock permettant de satisfaire au moins deux semaines de consommation; (afin de pallier une éventuelle pénurie) – livrer tout médicament du stock dans les 24h suivant la réception de la commande pour assurer la régularité d'approvisionnement des officines • Depuis le 24 août 2008, les grossistes-répartiteurs ont l'obligation de participer à un système d'astreinte les week-ends et jours fériés pour permettre la livraison des médicaments dans les situations d'urgence.

Attributions du PR dans ces entreprises	• Organise et surveille l'ensemble des opérations de stockage, livraison, publicité et information. • Concourt au suivi et au retrait des lots (vigilances), (dans la notion de vigilance, que ce soit la pharmacovigilance ou la matériau-vigilance) à la distribution, l'exportation des médicaments et autres produits. • Veille aux bonnes conditions de transport (conservation, sécurité...) et aux respect des BP de distribution en gros (processus systématique d'évaluation, de contrôle, de communication et de revue des risques qualité du médicament tout au long du cycle de vie du produit).
---	---

B) Les dépositaires :

Définition CSP	• Dépositaire : entreprise se livrant, d'ordre et pour le compte d'un ou plusieurs exploitants de médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs ou d'un ou plusieurs fabricants ou importateurs d'objets de pansement ou articles présentés comme conformes à la Pharmacopée ou de POD, au stockage de ces médicaments et produits, objets ou articles dont elle n'est pas propriétaire, en vue de leur distribution en gros et en l'état. ➤ À la différence du grossiste-répartiteur qui détient le stock, le dépositaire lui n'en est pas propriétaire ➤ Il peuvent cumuler l'activité de dépositaire et de grossiste-répartiteur
Obligations légales	• Le dépositaire n'a pas d'obligations légales, car il n'est pas propriétaire de son stock. ≠ grossiste-répartiteur • Il signe simplement un contrat avec les laboratoires fabricants, qui définit un cahier des charges et fixe leur rémunération en fonction de la prestation. • Ils proposent leurs services dans le cadre de la vente directe aux officines (en sortie d'usines, pour les génériques ++) mais aussi auprès des grossistes-répartiteurs. • 85% des approvisionnements à l'officine transitent par les dépositaires

Résumer de l'ensemble du circuit de distribution pharmaceutique

- Sortie des usines
- Produits peuvent être stockés dans un premier temps chez des dépositaires qui eux même pourront acheminer les produits de santé vers les grossistes-répartiteurs ou directement à l'office (ventes directes)
- Grossistes-répartiteurs acheminent de manière régulière et sur des volumes plus petits, les produits de santé aux établissements de santé mais également l'officine.

Exemple de dépositaires : dépoLabo, PhoenixPharma...

À retenir

- La répartition pharmaceutique, achète aux laboratoires, gère, stocke, livre les produits de santé et les met à disposition des officines, hôpitaux, cliniques, dans des conditions garantissant la santé publique.
- Les établissements pharmaceutiques sont soumis à des règles particulières :
 - Catégories différentes selon les activités pratiquées
 - Présence d'un pharmacien responsable
 - Respect des BP

Chapitre 9 : La distribution au détail des produits de santé : La prescription

Objectifs	– Connaître le principe de classement des médicaments selon l'obligation ou non de prescription – Savoir quelles sont les obligations qui en découlent pour les prescripteurs
-----------	---

I.- Classification des médicaments :

Classification des médicaments (SP)	Lorsqu'elles autorisent la mise sur le marché d'un médicament, les autorités compétentes (ANSM ou EMA) précisent la classification du médicament en : - médicament non soumis à prescription médicale (attention : il existe en plus des médicaments à prescription facultative en France pour la prise en charge par la SS) - médicament soumis à prescription médicale • Sont soumises à prescription médicale obligatoire, les spécialités susceptibles de présenter directement ou indirectement un risque pour la santé, ou nécessitant une surveillance particulière, ou contenant des substances classées comme substances vénéneuses. • Les spécialités sont classées en fonction de leur degré de dangerosité.
Référentiel National	• Articles L. 5132-1, L. 5132-6, L. 5132-7, R. 5132-1, R. 5132-2 du CSP : précisent les règles de classification des médicaments et autres produits de santé. • Des arrêtés publient les listes de substances et produits concernés. • À chaque liste correspond une réglementation stricte, concernant la présentation, la prescription et les conditions de circulation et de détention de ces produits
Conventions internationales	<u>But</u> : lutte contre la toxicomanie et le trafic • Cadre juridique applicable aux drogues ⇔ 3 conventions internationales qui lient les États signataires et les obligent à une transposition dans leur législation interne (doit être traduit en droit national au sein de chaque pays) : - <u>1^{ère} convention</u> : Convention unique de Vienne sur les stupéfiants de 1961 (modifiée par un protocole en 1972) : • définit ce qu'est un stupéfiant : une substance figurant sur la liste des stupéfiants annexée à la convention de 1961 ; • principales substances placées sous contrôle : opium, morphine, héroïne, méthadone, codéine, cocaïne, cannabis... ; - <u>2^{ème} convention</u> : Convention de 1971 sur les substances psychotropes (action sur le psychisme et le SNC) • développement de l'industrie chimique et pharmaceutique => trafic de nouvelles drogues synthétiques, non visées par la Convention unique de 1961 ⇔ nouvelle convention - <u>3^{ème} convention</u> : Renforcement des dispositions par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988).
Le classement français	• Découle du classement international mais est encore plus strict. • Organisé par l'article L.5132-1 du CSP qui précise la catégorie générique des « substances vénéneuses », lesquelles regroupent : - les substances stupéfiantes, - les substances psychotropes, - les substances inscrites sur les listes I et II, - certaines « substances dangereuses ».

Médicaments classés sur les listes I et II

Définis à l'article L.5132-6 du CSP.

- Médicaments qui présentent pour la santé, des **risques directs ou indirects** et qui ne peuvent être délivrés **que sur ordonnance**, soit **renouvelable** (liste II), soit **non renouvelable** (liste I => une nouvelle prescription est nécessaire pour la poursuite du traitement).

Médicaments soumis à prescription médicale spéciale

Il s'agit :

- des **stupéfiants**
- des **assimilés stupéfiants**

→ Liste des stupéfiants placés sous **contrôle international** en vertu de la première convention : la **Convention unique sur les stupéfiants de 1961** (↔ lutte contre la toxicomanie et le trafic international).

Substances classées stupéfiants

- **Toutes les substances classées stupéfiants dans la convention de 1961** : coca, pavot à opium, cannabis ainsi que leur dérivés : morphine, héroïne, méthadone, cocaïne, cannabis et sa résine...
- **Certaines substances classées psychotropes dans la convention de 1971** mais sur lesquelles on a souhaité **instituer un contrôle fort** : hallucinogènes, amphétamines, MDMA (ecstasy) etc.
- Certaines substances **non classées au niveau international**, mais qu'il est apparu nécessaire de **contrôler au plan national** : champignons hallucinogènes, nouvelles drogues de synthèse...

Assimilés stupéfiants

- **Relèvent de la liste I** des substances vénéneuses, mais **sont partiellement soumis à la réglementation des stupéfiants** (rohypnol, subutex, buprenorphine (temgésic), tranxène, rivotril...).
- Cas particuliers, pour lesquels **certaines mesures restrictives** relevant de la réglementation des stupéfiants s'appliquent, **mais pas toutes**.

Substances classées psychotropes

- Essentiellement des substances **entrant dans la composition de tranquillisants ou d'hypnotiques** (benzodiazépine, barbituriques, etc.).
- Y figurent également des substances **non classées par la convention de 1971** (ex : zopiclone [imovane®]).

Médicaments soumis à prescription restreinte

L'AMM d'un médicament peut classer celui-ci dans une des catégories de médicaments soumis à **prescription restreinte** suivantes :

- Médicaments **réservés à l'usage hospitalier** (= la réserve hospitalière)
- Médicaments qui sont uniquement de **prescription hospitalière** = médicament prescrit seulement par un médecin qui exerce dans le milieu hospitalier et le patient devra venir chercher le médicament auprès de la pharmacie de l'hôpital
- Médicaments de **prescription initiale hospitalière** = la première prescription initiale de manière annuelle doit être faite par un médecin hospitalier
- Médicaments **réserves à certains spécialistes** : infectiologues, neurologues, psychiatres...
- Médicaments qui **nécessitent une surveillance particulière** de par leur éventuelles toxicités



=> Un même médicament **peut cumuler plusieurs prescriptions restreintes** (ex : réservé à certains spécialistes + surveillance + prescription initiale hospitalière = cumule 3 prescriptions restreintes)

II.- La prescription :

La prescription des produits de santé	
• Support écrit obligatoire ou facultatif. • <u>Obligatoire</u> – quand le produit est listé – et/ou en vue d'un remboursement /!\ sans prescription il ne peut jamais y avoir de remboursement • <u>Facultatif</u> – quand le produit n'est pas « listé » c'est à dire en vente libre – quand le produit n'est pas pris en charge par un organisme de protection sociale	

Ordonnance	• <u>Un support à deux missions</u> - garantir la protection de la santé - obtenir la prise en charge par les organismes de SS • L'ordonnance est le document qui indique la prescription. • Permet au malade de connaître son traitement et au pharmacien de lui délivrer.
Prescripteurs	• Les pharmaciens délivrent des médicaments relevant des listes I et II et des médicaments classés comme stupéfiants, sur prescription ou sur commande à usage professionnel des : - médecin (spécialistes ou généralistes) ; - chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire uniquement ; - sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 4151-4 ; (dans la pratique des SF) - vétérinaire pour la médecine vétérinaire. • <u>Récemment</u> : Cas des infirmiers/renouvellement des contraceptifs oraux sous certaines conditions (art. L. 4311-1 du CSP) et prescription substituts nicotiniques (à la femme enceinte notamment).
Art. R.5123-2 du CSP	• En règle générale, la prescription est renouvelable par période maximale d'un mois ou de trois mois (conditionnement > à un mois) dans la limite de 12 mois de traitement. • L'ordonnance est valable 1 an. • La durée maximale de la prescription peut être limitée dans certains cas (psychotropes, hypnotiques, anxiolytiques, barbituriques => pour éviter les phénomènes d'accoutumance).

Les types ordonnances	Il existe 5 types d'ordonnances	
	Ordonnance simple	classique
	Ordonnance sécurisée (stupéfiants)	• Réservée à la prescription des stupéfiants • Seuls des éditeurs agréés par l'AFNOR sont autorisés à fabriquer les ordonnances sécurisées.
	Ordonnance bi-zone	Pour les ALD : → partie haute ttt de l'ALD VS partie basse ttt hors ALD • Les ttt de l'ALD seront pris en charge à 100 % et les autres au tût de remboursement classiques
	Ordonnance des médicaments d'exception	Ordonnance à 4 volets
	Ordonnance électronique	Expérimentale pour l'instant avec une possibilité de généralisation l'année 2019

III.- Dispositions générales :

- S'appliquent à **tous les médicaments**, qu'ils soient de prescription obligatoire ou non, dès lors qu'ils sont présentés au remboursement par l'assurance maladie.
- Ces règles générales précisent que pour **permettre la première délivrance**, l'ordonnance doit être **présentée dans les 3 mois** (sauf pour les stupéfiants et produits hors listes, pour lesquels la présentation doit être beaucoup plus courte)

Éléments à figurer sur l'ordonnance

Pour permettre la prise en charge, l'ordonnance doit comporter un certains nombre de mentions légales obligatoires :

- **Identification du prescripteur** + son numéro Adelli
- **Date à laquelle a été établit la prescription** (puisque l'ordonnance est valable 1an)
- **Identification du malade** avec nom et prénom
- **Médicaments prescrits** (en nom de marque ou en dénomination commune, la forme, la posologie, la durée du traitement, les modes d'emploi ou bien le nombre d'unités de conditionnement)
- **Mentions** telles que à renouveler ou à ne pas renouveler, non substituable (dans le cas des générique), non remboursable et le nombre de renouvellement
- **Signature du prescripteur**

IV.- Dispositions applicables à certaines catégories de médicaments :

Médicaments des listes I et II	• Pour les médicaments des listes I et II : - Listes II peuvent être renouvelés - Listes I ne peuvent à priori pas être renouvelés • Cependant, le prescripteur peut s'opposer au renouvellement d'un produit de liste II et peut autoriser le renouvellement d'un produit de liste I => Il faudra simplement spécifier sur l'ordonnance « à renouveler » ou « à ne pas renouveler », et si le renouvellement est possible : le nombre de renouvellement. • Si nécessaire : en pédiatrie ++ l'âge/la taille/le poids du patient (pour les enfants de 0 à 14 ans, l'âge et le poids doivent être mentionnés).	
Médicaments soumis à prescription restreinte	• PH, PIH, RS, SP = prescription hospitalière, initiale hospitalière, réservée à des spécialistes, nécessitant une surveillance particulière • En fonction des spécialités concernées, il pourra être nécessaire de faire figurer un certain nombre de mentions particulières telles que : - spécialité du prescripteur - date à laquelle certains examens ont été ou doivent être effectués - service hospitalier responsable de la prescription initiale	
Médicaments classés comme stupéfiants	Ordonnance sécurisée	• La prescription doit être effectuée sur une ordonnance sécurisée • Comment est-elle sécurisée ? Elle est dans un papier particulier dit « infalsifiable » -> ni photocopiable, ni scannable, si c'est le cas, le document scanné ou photocopie apparaît tout noir. • Les mentions prévues pour les médicaments des listes I et II s'appliquent à la prescription de médicaments stupéfiants. • Doivent figurer, en outre, et en toutes lettres : - le nombre d'unités thérapeutiques par prise - le nombre de prises - le dosage des spécialités Dans un souci de sécurité : pour éviter que les chiffres ne soient modifiés (qu'un 4 devienne un 14) on écrit 4 en toute lettre -> « Q U A T R E » -> difficilement falsifiable

	Durée de prescription	- La durée de prescription ne peut en aucun cas excéder 28 j. - Mais elle peut être réduite à 7 ou 14 j pour certains médicaments (CSP).
	Fractionnement de la délivrance	Pour ces médicaments, la délivrance doit être fractionnée (décidée par arrêté ministériel, qui mentionne la durée de traitement maximum correspondant à chaque fraction). La fraction peut obliger le pharmacien à déconditionner-> seule circonstance dans laquelle le pharmacien est autorisé à déconditionner une spécialité pharmaceutique. Le prescripteur mentionne sur l'ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, il peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention "délivrance en une seule fois".
	Règle des 3 jours	L'ordonnance ne peut être exécutée dans sa totalité que si elle est présentée dans les 3 jours, sinon on délivre la quantité pour la durée qui reste à courir.
	Règle du non chevauchement	- Le renouvellement d'un médicament stupéfiant ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé, résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées. - Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance, sauf si le prescripteur en décide autrement par mention expresse portée sur l'ordonnance.
Médicaments d'exception	- Ils font l'objet d'une prescription spéciale sur une ordonnance spécifique dite « 4 volets ». - La prescription doit préciser l'indication pour laquelle le médicament est prescrit, ce qui permet de vérifier que la prescription est en adéquation avec les « indications précisées » par l'AMM et par la commission de transparence (CT) qui en a défini le remboursement. - Ces indications qui figurent sur la fiche d'information thérapeutique (FIT) qui est une aide au prescripteur afin qu'il puisse effectuer sa prescription de manière adaptée.	
Médicaments non listés	- Sont en vente libre, disponibles sans ordonnance, remboursables ou non. Souvent utilisés en automédication. <u>Il existe 2 catégories :</u> Médicaments conseils (= relèvent du conseil pharmaceutique) Médicaments grand public = ceux qui vont avoir l'autorisation de faire de la publicité dans les médias et pour lesquels on peut dédier une surface de vente libre dans l'officine)	

V.- Prescription des DM :

Peuvent être prescrit par les même professionnel de santé que les médicaments

- Médecins (avec une possibilité de prescription limité par le CSP, la déontologie et les règles de compétence, tout le monde n'est pas habilité à prescrire une prothèse)
- Sages-femmes (toujours dans la pratique de leur art)
- Chirurgiens-dentistes (toujours dans la pratique de leur art)
- Masseurs kinésithérapeute
- Infirmiers
- Pédiatures podologues (dans la pratique de leur art)

À retenir
- La prescription est étroitement encadrée par un certain nombre de règles qui sont, entre autre, fonction de la classification des médicaments en termes de santé publique. - La prescription engage la responsabilité morale, professionnelle et juridique du prescripteur qui doit la signer. - Elle sert à informer le patient, les praticiens susceptibles d'intervenir et les organismes sociaux chargés des remboursements, et est la condition de délivrance des produits listés par le pharmacien.

Chapitre 10 : La distribution au détail des produits de santé - La délivrance/dispensation

Objectifs	– La distribution au détail des médicaments : le monopole pharmaceutique – Les règles de délivrance : connaître les obligations qui en découlent pour les pharmaciens selon le classement des médicaments (avec obligation ou non de prescription)
-----------	--

I.- La distribution au détail - Médicaments :

Définitions	Art. L 5125-1 du CSP modifié par la loi du 29 décembre 2011 JO du 30 décembre 2011 • On entend par officine, l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'art. L. 4211-1, ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales etc.
Monopole pharmaceutique	En France, pour des raisons de santé publique, la pharmacie d'officine détient le monopole de la vente de médicaments (cela sous-entend une compétence reconnue des pharmaciens). • Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code : – La vente en gros, la vente au détail, y compris par internet, et toute dispensation au public des médicaments, des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée ainsi que des générateurs, trousses ou précurseurs (=produits pharmaceutiques); • Les pharmaciens ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits, articles, objets et appareils qui correspondent à leur champ d'activité professionnel : – Médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine – Objets et pansements, articles, conformes à la pharmacopée, – Insecticides et acaricides – Plantes médicinales de la Pharmacopée – Dispositifs de diagnostic in vitro (autotest) • Arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine, modifiée par l'Arrêté du 18 janvier 2016. • Des dérogations autorise certains médecins à détenir et éventuellement délivrer des médicaments dans des zone géographique non desservie par les officines. (de + en + rare)
Arrêté de 2016	1° Les médicaments à usage humain 3° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact (...) 5° Les DM à usage individuel, y compris les assistants d'écoute pré-réglés d'une puissance maximale de 20 décibels, à l'exception des dispositifs médicaux implantables 15° Les DM de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public (tests de grossesse, autotests) 18° Les appareils de désinfection, de désinsectisation et de dératisation... (...) 20° Les équipements de protection individuelle de protection solaire 21° Les équipements de protection individuelle d'acoustique adaptés au conduit auditif (...) 23° Les équipements de protection individuelle respiratoire 24° Les éthylotests

II.- Dispensation du Médicament

A) Rôle « exclusif » du pharmacien :

Dispositions transversales «fondamentales»	Code de la consommation • Obligation pré-contractuelle d'information • Obligations contractuelles : – Obligation générale d'information (du vendeur et du revendeur auprès de l'acheteur) – Obligation générale de prévention (produits et services /sécurité légitime)	
Ar. du 28 novembre 2016 relatif aux <u>BP de dispensation des médicaments</u>	• Entrées en vigueur le 01/02/17 : guide des bonnes pratique de dispensation • Précisent les différentes étapes de la dispensation des médicaments à prescription obligatoire ou facultative. • Envisagent la voie à suivre dans le cas de médicaments prescrits hors de l'UE. • Précisent la définition du conseil pharmaceutique. • Introduisent l'obligation de mettre en place une procédure de traitements des alertes sanitaires.	
Acte pharmaceutique / déontologie	Acte de dispensation = acte intellectuel = acte pharmaceutique lié à des règles de déontologie • Le pharmacien doit assurer, dans son intégralité, l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : 1º L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ; 2º La préparation éventuelle des doses à administrer (préparations magistrales de gélules, de sachets, de paquets etc...) 3º La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament (BUM). • Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale. • Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.	
L'analyse pharmaceutique de la prescription	• <u>Trois validations de la prescription avant toute dispensation :</u> – Validation de l'habilitation du prescripteur à prescrire (professionnel médical, médecin généraliste ou spécialiste, ou auxiliaire médical) est-il bien autorisé à prescrire ? – Validation scientifique pour la sécurité du patient – Validation légale de la présence des mentions obligatoires.	
	Sur le plan réglementaire	Vérifier que rien n'interdit la délivrance des médicaments prescrits (prescripteurs, identifiants du patient, du service...) → Doit refuser l'ordonnance si non-conforme → Doit prendre contact avec le prescripteur pour apporter les modifications nécessaires
	Sur le plan pharmaco-thérapeutique	→ Vérifier les contre-indications en fonction de la physiopathologie du patient → Appréhender les interactions médicamenteuses → S'assurer des bonnes posologies et des bon modes d'administration
	• Lors de l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance, le rôle du pharmacien est, entre autre, de procéder aux vérifications réglementaires de la prescription. • Il peut et doit refuser la délivrance en cas de non-conformité aux obligations réglementaires liées au(x) médicament(s) prescrit(s), et prendre contact avec le prescripteur afin qu'il y apporte les modifications nécessaires.	

Les <u>problèmes</u> qui peuvent être rencontrés par rapport à la prescription	- Non-conformité aux référentiels - Contre-indications - Une indication qui n'est pas traitée - Mauvaise posologie, sous dosage/surdosage - Médicament n'est pas indiqué correctement ou avec une interaction à prendre en compte - Une précaution d'emploi - Une association déconseillée ou une association contre indiqué - Certains effets indésirables - Une voie ou une administration inappropriée - Un traitement qui n'a pas été reçu		
Les <u>solutions</u>	- Ajout d'une prescription - Arrêt d'une prescription - Substitution / échange - Nouvelle voie d'administration - Suivi thérapeutique - Optimisation des modalités d'administration - Adaptation posologique		
Conservation des prescriptions	• Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances les enregistrent sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. • Les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle (inspecteurs de santé publique) pendant la durée prescrite. <table border="1" data-bbox="316 869 1511 1099"> <tr> <td><u>Stupéfiants</u></td><td> • Pour les stupéfiants, toute entrée et toute sortie doit spécifiquement être inscrite par le pharmacien sur le registre comptable des stupéfiants. • L'inscription des entrées et des sorties se fait à chaque opération en précisant la date à laquelle elle est établie. • Une balance mensuelle des entrées et des sorties est portée sur le registre des stupéfiants, et un inventaire annuel du stock est obligatoire. </td></tr> </table>	<u>Stupéfiants</u>	• Pour les stupéfiants, toute entrée et toute sortie doit spécifiquement être inscrite par le pharmacien sur le registre comptable des stupéfiants. • L'inscription des entrées et des sorties se fait à chaque opération en précisant la date à laquelle elle est établie. • Une balance mensuelle des entrées et des sorties est portée sur le registre des stupéfiants, et un inventaire annuel du stock est obligatoire.
<u>Stupéfiants</u>	• Pour les stupéfiants, toute entrée et toute sortie doit spécifiquement être inscrite par le pharmacien sur le registre comptable des stupéfiants. • L'inscription des entrées et des sorties se fait à chaque opération en précisant la date à laquelle elle est établie. • Une balance mensuelle des entrées et des sorties est portée sur le registre des stupéfiants, et un inventaire annuel du stock est obligatoire.		
Conditions de dispensation	• Pour le pharmacien, la prise en charge de l'ordonnance est possible pendant toute la validité de celle-ci c'est à dire un an à partir de la date de prescription. Il n'y a que la dispensation (= délivrance) qui s'effectue pour des périodes de 1 à 3 mois. • Il est interdit au pharmacien de délivrer un médicament non autorisé (cad sans AMM pour l'indication concernée), en dehors de la procédure de la prescription hors AMM (rôle majeur du prescripteur => information du patient).		
Médicaments en libre accès	• Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discretion que requiert le respect du secret professionnel. • Toutefois, depuis le décret du 30 juin 2008, le pharmacien peut rendre directement accessibles au public les médicaments de médication officinale.		
Quels médicaments en libre accès ?	• Tous médicaments définies au CSP et dont l'AMM n'indique pas qu'ils sont soumis à prescription • Tous ceux dont les indications thérapeutiques, les durées de traitement et les informations qui figurent sur la notice permettent leur utilisation, avec le conseil particulier d'officine, sans qu'une prescription médicale n'ait été établie • Produits dont le contenu du conditionnement en poids, volume, nombre d'unité de prise soit adapté à la posologie et à la durée du traitement recommandée dans la notice • Il faut que l'AMM ou la décision d'enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque éventuel pour la santé publique => L'ANSM gère la liste des médicaments concernés. Ce sont donc des produits d'automédication courant dont le risque toxique est très faible voire nul.		
Liste du libre accès	• <u>La liste contient :</u> - des spécialités pharmaceutiques (aciclovir, drill, humex, maalo, minoxidil, nicopatch, nicorette, nurofen, sargenor, strepsils...) - des médicaments homéopathiques (arnigel, sédatif PC, tabapass...) et, - des médicaments à base de plantes (arkogélules, arnica, euphytose...). L'inscription sur cette liste est une démarche volontaire du laboratoire, validée par l'ANSM.		

Dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux	• Possibilité est offerte au pharmacien pour permettre la poursuite d'un traitement contraceptif, de dispenser, pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois, les contraceptifs oraux figurant sur une ordonnance datant de moins d'un an, dont la durée de validité a expiré, sauf s'ils figurent sur une liste qui les exclue de cette possibilité, fixée par un arrêté du ministre de la santé sur proposition de l'ANSM.
La vente par internet	• Suite aux dispositions de l'arrêt de la CJUE connu sous le nom « Arrêt Doc Morris » de décembre 2003, la vente par internet de certains médicaments est possible en France. • Officialisée par l'Ordonnance du 19 décembre 2012 et le Décret n° 2012-1562 du 31 décembre 2012 relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet (vente à distance). • Entrée en application le 2 janvier 2013 • <u>Conditions :</u> – seuls les médicaments non soumis à prescription obligatoire peuvent être vendus par internet – la vente par internet s'effectue à partir d'un site officiel, labellisé, autorisé par l'ARS • Autorisés, les pharmaciens d'officine doivent informer l'Ordre des pharmaciens de la création du site. • L'Ordre tient à jour la liste des sites autorisés. La liste est également disponible sur le site du Ministère de la santé. Depuis juillet 2015, les sites de vente en ligne autorisés, doivent afficher sur chaque page du site qui a trait au commerce électronique de médicaments, le logo commun à tous les États membres de l'UE.



III.- Dispensation / Délivrance du DM :

- Sauf exceptions, les DM **ne relèvent pas du monopole pharmaceutique**. ≠ médicaments
- Ils **peuvent être distribués et vendus en officine, mais aussi ailleurs qu'en pharmacie**.
- Certains peuvent ainsi être prescrits par des professionnels de santé autres que les médecins (sages femmes, kinésithérapeutes, podologues ...).

Délivrance du Dispositif Médical	• Les prestataires de services et distributeurs de matériels (PSDM), [y compris les dispositifs médicaux destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap], doivent disposer de personnes compétentes. • Quels personnels compétents? Quatre catégories de produits associés à Quatre catégories de personnels garants de l'application des règles professionnelles et de bonne pratique. • Le pharmacien est celui qui peut distribuer l'intégralité des produits.
	<u>Catégorie 1</u> La catégorie 1 concerne les pharmaciens disposant d'un diplôme, titre ou certificat les autorisant à exercer en France. Pour la catégorie 1 (pharmaciens) : – les dispositifs médicaux d'oxygénothérapie (pour cette catégorie : monopole pharmaceutique) – les systèmes actifs pour perfusion – les matériels pour nutrition entérale – les appareils de ventilation – les appareils pour pression positive continue – les dispositifs médicaux d'aérosolthérapie pour pathologies respiratoires chroniques

Le pharmacien et le DM	• Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée. • L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste, pour celui-ci, à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même. • Le pharmacien a obligation, comme pour tout produit, d'informer du prix et du mode d'utilisation. Il doit aussi vérifier que le patient va pouvoir utiliser le matériel à domicile. • Il doit donner au patient le numéro du fournisseur qui se charge, lui-même, en cas de problème, de la réparation et du remplacement si besoin. • Enfin le pharmacien est responsable de la stérilité du matériel.
------------------------	--

À retenir
• La dispensation au détail des médicaments est réservée par la loi aux pharmaciens d'officine en raison de leur compétence scientifique et doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques. • Elle doit contribuer à une efficacité optimale des traitements et à une diminution des risques de iatrogénie médicamenteuse. • L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance permet la vérification – des posologies, – des doses, – des durées de traitement, – du mode et des rythmes d'administration, – de l'absence de contre-indications, d'interactions – et de redondances médicamenteuses.

Chapitre 11 : Les produits de santé : Utilisation - Publicité- Promotion

Objectifs	– Connaître la réglementation qui s'applique à l'information et à la publicité sur les différents produits de santé. – Savoir quelles sont les missions et les décisions de la Commission chargée du contrôle de la publicité et les règles qui concourent au « Bon Usage du Médicament ».
-----------	--

I.- Publicité/Promotion : Généralités :

Définition de la Publicité par le Code de la consommation	• On entend par publicité : – toute forme d'information, y compris le démarchage, – de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la vente (mais aussi pour les professionnels de santé la prescription, la délivrance ou l'utilisation). • C'est une pratique commerciale. • L'article L. 121-1 du Code de la consommation pose un principe général d'interdiction des pratiques commerciales déloyales (trompeuses ou agressives). • Une <u>pratique commerciale est trompeuse</u> : – lorsqu'elle crée une confusion – lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur – lorsqu'elle formule des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille, s'il n'achète pas le produit ou le service.
Sanctions/Code de la Consommation	• Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1. – Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers... • L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

II.- Publicité des médicaments :

Publicité/ Définitions CSP 	• « On entend par publicité pour les médicaments à usage humain, toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation, qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une PUI. » • <u>Ne sont pas incluses dans le champ de cette définition</u> : - la correspondance nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier, émanant d'un professionnel de santé. - des informations concrètes et des documents de référence sur des sujets sans rapport avec quelque prospection ou incitation que ce soit (changements d'emballages, mises en garde concernant les effets indésirables, catalogues de vente, listes de prix...) - des informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, à condition que ces informations ne contiennent aucune référence, même indirecte, à un médicament. <u>Ex :</u> campagne d'information sur la grippe, le diabète, affiche de sensibilisation à l'arrêt du tabac...
--	--

Produits visés	Selon l'article L. 5122-3 du CSP : • Seuls les médicaments ayant obtenu l'AMM peuvent faire l'objet de publicité • <u>Mais aussi</u> : - les produits pour lentilles de contact, - les pédiculicides et les acaricides (= anti poux et anti galle) - les générateurs, les trousses et précurseurs - les produits et objets contraceptifs (autres que les médicaments)
ANSM : Commission(s) de contrôle de la Publicité	• Le contrôle de la publicité des produits de santé est exercé par l'ANSM (par le biais de sa Commission du contrôle de la publicité). • L'Agence : - s'assure que les messages promotionnels délivrés, aux prescripteurs et au grand public, ne sont pas trompeurs et ne présentent pas de danger pour la santé publique. - formule des avis sur les pratiques promotionnelles concernant le médicament. - émet des recommandations sur le bon usage du médicament.
Publicité : Caractéristiques	• La publicité définie à l'article : – ne doit pas être trompeuse (ex : omettre d'indiquer la significativité des résultats d'une étude clinique par l'absence du seuil de significativité (p)). – ni porter atteinte à la protection de la santé publique (ex : omettre de présenter des résultats défavorables en matière de tolérance en occultant les effets indésirables graves). • La publicité doit : – présenter le médicament ou le produit de façon objective (ex : omettre de présenter un groupe de patients présentant des résultats défavorables ou, choisir l'étude particulièrement favorable alors que toutes les autres présentaient des résultats défavorables). – favoriser son bon usage en respectant l'AMM et l'avis de la commission de transparence... – respecter les dispositions de l'AMM.
Le support publicitaire	• Le support de la publicité peut être : - une annonce dans la presse médicale, - toute information promotionnelle diffusée auprès des professionnels de santé, à l'occasion : - o de la présentation du médicament à des professionnels de santé par des délégués médicaux, - o des études, enquêtes auprès des professionnels, - o des réunions, congrès scientifiques ou émissions télévisées destinées aux professionnels de santé, particulièrement lorsque ceux-ci font l'objet d'un « parrainage » (contribution au financement).
Conditions de forme	• La publicité pour les médicaments est soumise à un visa de publicité. • Dépôt du projet relatif au médicament et à son emballage, à la commission de contrôle de la publicité de l'ANSM. • Si celle-ci accepte, « le visa » est délivré par le ministère de la santé. Ce visa peut être retiré en cas de non respect des conditions publicitaires. • Le contenu de la publicité varie en fonction, du destinataire : consommateur ou professionnel.
Publicité auprès des Professionnels de santé	• La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments, ou à les utiliser dans l'exercice de leur art, est soumise à une demande d'autorisation préalable de l'ANSM dénommée « visa de publicité médicale » ou « Visa PM », d'une validité de 2 ans. => il s'agit d'un visa à priori
Publicité auprès du Grand public	• La publicité auprès du public pour un médicament mentionné à l'article L. 5122- 6 (non PMO, ni remboursable SS, ni interdiction ou restriction sur AMM), ainsi que les campagnes publicitaires pour certaines vaccinations, sont soumises à une autorisation préalable de l'ANSM dénommée « visa de publicité Grand Public » ou Visa GP, d'une validité de 2 ans.

III.- Publicité des DM :

Dispositions propres aux DM	- La réglementation de la promotion des DM est beaucoup plus récente que celle des médicaments. - La loi du 29 décembre 2011 (loir Bertrand) [relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé], a introduit des dispositions concernant la publicité pour les DM, entrées en vigueur au 1er janvier 2013. - La publicité fait, selon le cas, l'objet d'un contrôle a priori ou a posteriori par l'ANSM.	
Définition/CSP	« On entend par publicité pour les DM/DMDIV, toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation, qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou l'utilisation de ces dispositifs, à l'exception de l'information dispensée dans le cadre de leurs fonctions par les pharmaciens gérant une PUI. » (semblable à celle proposé pour les médicaments) <u>Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :</u> L'étiquetage et la notice d'instruction ; - La correspondance nécessaire pour répondre à une question précise sur un DM/DMDIV particulier, d'un professionnel de santé ; - Les informations relatives aux mises en garde, aux précautions d'emploi et aux EI relevés dans le cadre de la matériovigilance, ainsi que les catalogues de ventes et listes de prix s'il n'y figure aucune information sur le DM/DMDIV ; - Les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence, même indirecte, à un DM/DMDIV.	
Publicité auprès des Professionnels de santé	Tous les DM (remboursables/non remboursables) peuvent faire l'objet de publicité auprès des PS. - Pour certains DM présentant un risque important pour la santé publique et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (implants mammaires, produits de comblement des dépressions cutanées, défibrillateurs cardiaques, stents, etc.), la publicité est soumise à autorisation préalable de l'ANSM (contrôle a priori) qu'ils soient remboursables ou non. - Pour les autres, contrôle a posteriori	
Publicité auprès du Grand public	DM remboursables	La publicité auprès du GP est interdite, sauf si ces DM sont inscrits sur une liste de DM présentant un faible risque pour la santé humaine (classes I et IIa). Ces publicités font l'objet d'un contrôle a posteriori et ne nécessitent pas de dépôt à l'ANSM.
	DM non remboursables	- DM non remboursables inscrits sur la liste des DM présentant un risque important pour la santé humaine, (produits de comblement des dépressions cutanées notamment), la publicité auprès du GP est soumise à autorisation préalable de l'ANSM (contrôle a priori). - Autres DM non remboursables : les publicités font l'objet d'un contrôle a posteriori et ne nécessitent pas de dépôt à l'ANSM.
Préservatifs/ contraceptifs	- La publicité des préservatifs et contraceptifs autres que les médicaments, auprès des professionnels de santé, est soumise, au même titre que les médicaments, à un contrôle a priori. - La dénomination « visa PR » traditionnellement usitée pour les publicités des préservatifs auprès du public est étendue aux publicités en faveur des contraceptifs autres que médicaments (notamment les DIU).	
DMDIV	Tous les DMDIV peuvent faire l'objet de publicité auprès du grand public (autotests). - La publicité auprès des PS pour les DMDIV dont la défaillance est susceptible de causer un risque grave pour la santé humaine (réactifs pour certains groupes sanguins, marqueurs, HIV, hépatite etc.), est soumise à autorisation préalable de l'ANSM. - Les autres DMDIV font l'objet d'un contrôle a posteriori et ne nécessitent pas de dépôt à l'ANSM.	

IV.- Activité promotionnelle des laboratoires = Publicité - Charte de la visite médical :

Promotion/ Responsabilité	- Les entreprises pharmaceutiques ont l'obligation de se doter d'un service chargé de la publicité placé sous le contrôle du pharmacien responsable, qui s'assure du respect des dispositions du CSP encadrant la publicité des médicaments, et notamment de la validité scientifique des informations diffusées. - Ainsi, au sein de l'entreprise, c'est le pharmacien responsable qui est le garant de l'information concernant le médicament, ainsi que de la promotion.
Publicité/ Promotion	- Conformément à l'art. L.162-17-8 du Code de la SS, une Charte de la visite médicale a été signée en 2004 entre les entreprises du médicament et le CEPS. - Objectif principal : « renforcer le rôle de la visite médicale dans le bon usage des médicaments remboursés aux assurés sociaux, et la qualité de l'information délivrée ». - La HAS a rédigé un référentiel de certification sur la base duquel des organismes accrédités par le COFRAC certifient les entreprises ayant une activité de visite médicale.

Charte d'octobre 2014	Charte de «l'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments ». - Se substitue à celle de 2004 et s'applique à l'ensemble des métiers qui relèvent de « l'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments » - Établit un certain nombre de dispositions nouvelles relatives à la qualité de l'information, au bon usage du médicament et à l'indépendance des professionnels de santé
Charte et DM	LFSS 2018 : adoption d'un article visant à créer une « Charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de l'information ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de services et d'adaptation éventuellement associée ».
Publicité/ Promotion	- Encadrement de la promotion et des pratiques visant à favoriser l'octroi d'avantages financiers ou en nature (voyages, cadeaux, invitations...) à des professionnels de santé. – <u>1993 modifié 2007</u> : Loi DMOS (loi portant sur diverses mesures d'ordre social) = Loi anti-cadeaux - Article L1453-1 CSP – <u>2011</u> : Obligations de déclaration des avantages consentis par les entreprises auprès des PS ou « Sunshine Act à la française » ⇔ plus grande transparence des liens entre les acteurs.
Disposition anti-cadeaux	- Réglementation s'appliquant à tous les produits de santé pris en charge par l'AM. « Est interdit le fait, pour les étudiants se destinant aux professions [de santé] et pour les membres des professions médicales [...], ainsi que les associations les représentant, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages. » <u>Loi du 4 mars 2002</u> : – a élargi les sanctions, jusqu'ici réservées aux professionnels de santé, aux entreprises proposant des avantages prohibés. – a étendu l'interdiction de percevoir des avantages, à certains acteurs de la politique institutionnelle de la santé, tels les experts et les collaborateurs occasionnels scientifiques ou techniques d'agences (comme l'ANSM par ex).

	• <u>Loi du 29 décembre 2011</u> : – étend la liste des personnes concernées par les dispositions anti-cadeaux (étudiants des professions de santé). – nouvelles mesures visant à renforcer la transparence entre les acteurs : ○ les entreprises doivent publier l'existence des conventions qu'elles concluent avec les professionnels de santé, les étudiants, les associations etc., et sont tenues de rendre publics les avantages qu'elles procurent.
Prévention et transparence des conflits d'intérêt	• <u>Décret du 21 mai 2013</u> (relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l'homme) : – obligation d'une déclaration publique d'intérêts qui mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que les professionnels ont ou ont eus avec des entreprises du secteur de la santé pendant les cinq années précédant leur prise de fonctions. – liens d'intérêt consultables sur : www.transparence.sante.gouv.fr
Les échantillons	• Art. L. 5122-10 du CSP – des échantillons gratuits de médicaments ne peuvent être remis aux PS que sur leur demande. Ils doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter sur l'emballage la mention "échantillon gratuit". • Art. R. 5122-17 du CSP (décret du 9 mai 2012) : – seuls les nouveaux médicaments peuvent faire l'objet d'une remise d'échantillons aux PS, pendant les 2 ans suivant la 1^{ère} commercialisation en France, – limité à quatre par an et par destinataire, – de la plus petite présentation et du plus faible dosage

À retenir

- La publicité des produits de santé est assujettie à un contrôle fondé sur la distinction du destinataire.
- Qu'elle soit destinée au grand public ou aux professionnels de santé, elle est soumise à un visa préalable délivré par l'ANSM dont le rôle tient dans la sécurisation du message promotionnel.
- Elle ne doit être ni trompeuse, ni porter atteinte à la santé publique, mais doit être objective et respecter les indications de l'AMM.
- Le renforcement de la sécurité sanitaire des médicaments à travers la loi Bertrand, a abouti à une attention accrue des pouvoirs publics envers les pratiques promotionnelles des laboratoires pharmaceutiques (loi DMOS/Sun Shine Act).

Chapitre 12 : Les produits de santé- Utilisation- Surveillance (les vigilances) - L'élimination

Objectifs	– Définir les principaux termes utilisés en pharmacovigilance/matéiovigilance. – Décrire l'organisation et les missions de la pharmacovigilance en France, et ses connexions avec les structures européennes. – Connaître les obligations des professionnels de santé en termes de pharmacovigilance et de matéiovigilance. – Connaître le circuit d'élimination des médicaments.
-----------	---

I.- La pharmacovigilance :

Définition	« Ensemble des procédures, méthodes ou techniques visant à surveiller, évaluer, prévenir et gérer le risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments, que ce risque soit potentiel ou avéré . Pour les médicaments mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit »
Organisation	• La pharmacovigilance repose avant tout sur le signalement des effets indésirables susceptibles d'être dus aux médicaments ou produits mentionnés à l'article L.5121-1 du CSP. • Obligation de déclaration des professionnels de santé dès qu'ils soupçonnent un lien, même s'il n'est pas certain
Obligation de déclaration	Art R 5121-151 modifié par décret du 8 novembre 2012 • Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou le pharmacien déclarent immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou à un produit dont ils ont connaissance.
Que faut-il déclarer ?	Toute suspicion : – d'effet indésirable médicamenteux, – d'erreur médicamenteuse, – de mésusage, d'abus, de surdosage, – d'exposition professionnelle à un médicament – que l'effet soit connu ou non, qu'il soit grave ou non.

Définitions	
Effet indésirable	– réaction nocive, non voulue à un médicament, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou pour le rétablissement, la rectification ou la modification d'une fonction physiologique. • <u>Élargissement de la définition de l'EI :</u> – couvre dorénavant les réactions nocives survenues dans toutes les situations d'utilisation (mésusage, abus, surdosage, erreurs médicamenteuses, absence d'effet thérapeutique, rumeurs, mauvaise observance, exposition professionnelle, rupture de la chaîne du froid...).
Effet indésirable grave	– entraînant le décès ou mettant en jeu le pronostic vital ou entraînant une invalidité ou une incapacité significative ou entraînant/prolongeant une hospitalisation ou entraînant une anomalie ou malformation congénitale .
Effet indésirable inattendu	– dont la nature, la gravité, l'effet, l'évolution, ne concordent pas avec le RCP .
Mésusage	– Utilisation intentionnelle et inappropriée d'un médicament ou d'un produit, non conforme à l'AMM ainsi qu'aux recommandations de bonnes pratiques (non conforme au RCP).
Imputabilité	– analyse au cas par cas du lien de causalité entre la prise d'un médicament et la survenue d'un événement indésirable

A) Pharmacovigilance en France :

Organisation	Elle comporte (Art. R 5121-151 CSP) : • Le signalement des effets indésirables et le recueil des informations les concernant ; • L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ; ces informations sont analysées en prenant en compte les données disponibles concernant la vente, la délivrance et les pratiques de consommation, de prescription et d'administration aux patients des médicaments et produits ; • La réalisation de toutes études et travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments
Acteurs	Le système national comprend : • L'ANSM • Le Comité technique (assure l'interface avec les réseaux de terrain) • Les Centres régionaux • Les membres des professions de santé, les entreprises ou organismes exploitant un médicament, ainsi que les PUI • Sans oublier les patients et les associations de patients
Le système français	<u>Se caractérise par :</u> - un réseau de 31 CRPV (basés dans les CHU) - l'emploi, par tous les spécialistes concernés, d'une méthode d'imputabilité commune imposant un contrôle de qualité des informations recueillies, de façon à pouvoir établir un score évaluant la relation de causalité entre un événement indésirable et un ou des traitements - la centralisation et l'évaluation de l'ensemble de ces données par l'ANSM Organisation française
Commission de suivi du rapport bénéfices/risques	• Consultée si sont envisagés : – une réévaluation du rapport B/R – des modifications substantielles des AMM notamment sur les rubriques de sécurité figurant dans les RCP – des modifications des conditions de prescription et de délivrance produits de santé – l'élaboration ou la mise à jour de certains plans de gestion des risques de médicaments déjà autorisés (sauf médicaments psychoactifs) – la surveillance et le contrôle de certains dispositifs médicaux – certains arrêts de commercialisation
Exigences communautaires	• Système de gestion de risque pour chaque médicament dont : – plans de gestion des risques (PGR) et – mesures de minimisation des risques (MMR) • Mise en place d'un système de Pharmacovigilance • Personne qualifiée responsable de la pharmacovigilance • Tenue d'un dossier permanent du système de pharmacovigilance pour tout médicament

Déclaration des EI	• Pour faciliter la déclaration/notification des effets indésirables, depuis mars 2017, les professionnels de santé et usagers peuvent signaler en quelques clics aux autorités sanitaires tout évènement indésirable sur un site dédié : signalement-santé.gouv.fr et notamment les effets indésirables, incidents ou risques d'incidents liés aux produits de santé. → Ceci est mis en place pour faciliter la déclaration qu'on estime en général insuffisante → Une fiche de déclaration d'effet indésirable se présente toujours de la même manière et elle comporte <u>4 éléments essentiels</u> : - o Un notificateur - o Un effet - o Un produit - o Un patient
Les décisions	Quelles sont les décisions qui peuvent être prises ? - Retrait de lot (notamment dans des problématiques de fabrications industrielles) - Modification du RCP (modification qualitative/quantitative des effets indésirables) - Modification du conditionnement (quand on se rend compte qu'il est responsable de mésusage) - Restriction de prescription ou restriction d'utilisation - Suspension ou retrait d'AMM (elle peut être au maximum d'un an, au-delà c'est un retrait définitif)

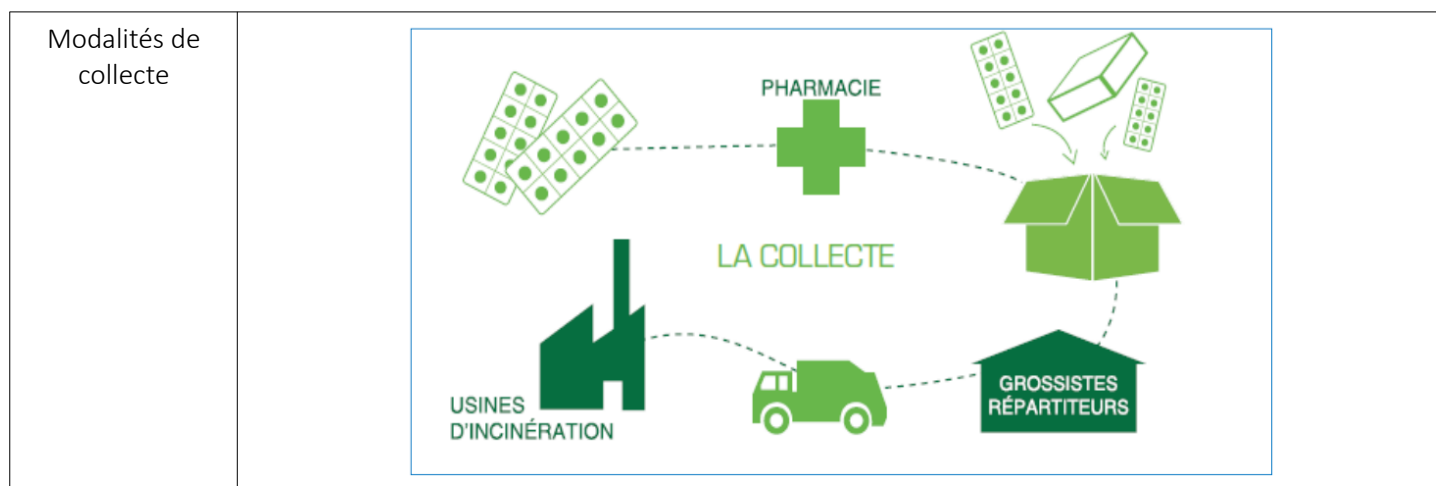
II.- Matéiovigilance : vigilance relative aux DMs :

Définition	• Mises en place par un décret en 1996 modifié en 1999. • Elle concerne la surveillance et la prévention des incidents/risques d'incidents qui résultent de l'utilisation des DM. • Elle ne concerne que les DM après leur mise sur le marché. <u>Objectif :</u> - Éviter que ne se produise voire reproduise des incidents graves, qui mettent en causes de DM - Prendre des mesures préventives et éventuellement correctives appropriées
Organisation	Comme pour la pharmacovigilance, elle comporte le signalement, l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation des informations signalées dans un but de prévention
Acteurs	• <u>Échelon national</u> – l'ANSM • <u>Échelon local</u> – correspondants locaux de matériovigilance des établissements de santé, – fabricants, – quiconque ayant connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident : les utilisateurs et les tiers.
Domaine d'application	• S'applique à tous DM tels que définis à l'article L.5211-1 du CSP notamment : – les consommables à usage unique ou réutilisables – les implants passifs ou actifs – les équipements • L'évaluation doit essayer de répondre aux questions suivantes : – le DM peut-il être en cause ? – le risque d'incident ou l'incident est-il grave ? – le risque d'incident ou l'incident est-il reproductible ?

Obligations réglementaires selon le CSP	Art L.5212-2 : • Signalement obligatoire et sans délai – d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un DM ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers doivent le signaler sans délai à l'autorité administrative. – Tout rappel de dispositif du marché, motivé par une raison technique ou médicale. Article R.5212-15 : • Les autres événements indésirables peuvent être signalés selon une périodicité trimestrielle et de manière facultative. (à la libre appréciation du correspondant local de matériovigilance)
Obligations réglementaires au niveau européen	Le règlement (UE) 2017/745 (obligatoire à compter de mai 2020), modifie les règles de matériovigilance. • Matériovigilance au cas par cas : – Les fabricants devront notifier via Eudamed à l'ANSM les éléments suivants : • tout incident grave ; • toute mesure corrective de sécurité prise à l'égard d'un dispositif présent sur le marché de l'UE ; • la notification sera faite dès l'établissement de l'imputabilité et en tout état de cause dans des délais allant de 2 à 15 j
Surveillance après commercialisation	• Pour chaque dispositif, les fabricants conçoivent, établissent, documentent, appliquent, maintiennent et mettent à jour un système de surveillance après commercialisation en fonction de la classe de risque et du type de dispositif. • classes Ia, Ib, III → rapport périodique actualisé de surveillance • classe I → rapport sur la surveillance font la synthèse des résultats et des conclusions de l'analyse des données de surveillance exposant la justification de toute mesure préventive ou corrective prise et les décrivant.

III.- Élimination ou Responsabilités élargies des producteurs (REP) : médicaments et DM :

Définition REP	• = Ensemble des démarches et dispositifs qui restaurent la responsabilité du producteur de produits manufacturés pour ce qui concerne la gestion des déchets finaux ou intermédiaires générés par les produits qu'il a fabriqués ou mis sur le marché. • Pour réduire la production de déchets.
Cadre réglementaire	• La directive 2004/27/CE prévoit que tout EM de l'UE doit veiller à « la mise en place de systèmes de collecte appropriés pour les médicaments inutilisés ou périmés ». • En France, il a été décidé de rendre obligatoire la mise en place d'une filière REP pour la gestion des MNU. (Médicament Non Utilisés) • L'art. 32 de la loi n° 2007-248 indique que toute pharmacie française a l'obligation de collecter gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés, rapportés par les particuliers (sans les emballages en carton).
Organisation	• En France, l'association Cyclamed est à l'origine du dispositif de collecte spécifique des MNU depuis 1993. • Regroupe l'ensemble des acteurs de la profession pharmaceutique – pharmaciens, – grossistes répartiteurs – laboratoires pharmaceutiques (au nombre de 192 en 2014 à participer). • Élimination des déchets par incinération dans la plupart des cas



Élimination	
Élimination des médicaments	Élimination des DM
Cas spécifique d'élimination de médicaments dans un but de protection de la personne :	
Cas des stupéfiants Les pharmaciens sont les garants de la mise en œuvre de la réglementation en matière de stupéfiants . – Procédure de dénaturation mise en place par l'Ordre des Pharmaciens – Conservation des produits concernés dans une armoire ou un local fermé à clef – À l'officine, le pharmacien titulaire doit solliciter le Conseil régional de l'Ordre afin qu'il désigne un pharmacien « témoin » – Le pharmacien "demandeur" choisit le procédé de dénaturation le plus adapté pour rendre les produits concernés définitivement inutilisables à quelques fins que ce soit – Procès verbal établi et conservé 10 ans	• L'élimination des DM après utilisation, s'intègre dans la démarche générale de l'élimination des déchets de soins. • La réglementation repose à la fois sur le code de l'environnement et sur la notion de déchet ultime qui y est définie, avec le respect de 4 principes : – prévention ou réduction des déchets, – organisation de leur transport, – valorisation énergétique, recyclage – information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique L'élimination des DM relève : • Soit des dispositions spécifiques aux déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI), définis aux Art R1335-1 à R 1335-14 du CSP, en particulier pour tous les DM à risque d'accident d'exposition au sang et tous ceux ayant collectés des liquides biologiques potentiellement pathogènes . • Soit de dispositions spécifiques inhérentes aux produits « toxiques » (mercure, piles, émission de radiations diverses, etc.). • Soit des démarches de valorisation pour les DM d'équipements en particulier.
Certains pacths	Destruction par découpage avant incinération avec les ordures ménagères.

À retenir
• L'ANSM exerce une surveillance de tous les médicaments, à tous les stades de leur cycle de vie, en partenariat avec le réseau des CRPV, et ses partenaires européens. • Elle s'intéresse aux effets indésirables survenant dans les conditions normales d'utilisation du médicament, mais aussi aux effets indésirables survenant dans le cadre d'erreur médicamenteuses, d'abus, de mésusages, de surdosages et d'expositions professionnelles. • La notification spontanée, base du système de pharmacovigilance, repose sur la participation des professionnels de santé, qui ont obligation de déclaration, et jouent un rôle fondamental dans le système national de pharmacovigilance. • En France, la filière REP, rendue obligatoire pour la gestion des MNU, fait intervenir l'ensemble des acteurs de la profession pharmaceutique.

